

国健医疗

四诊合参体质辨识报告

开封市龙亭区 1234452345

患者信息:

姓名:	唐霄	性别:	男	年龄:	19岁	生日:	2006-09-27
住址:	河南省固始县方集镇白果村黄湾队						

中华人民共和国居民身份证

姓名 唐霄

性别 男 民族 汉族

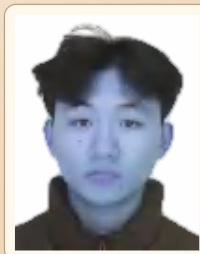
出生 2006-09-27

住址 河南省固始县方集镇白果村黄湾队

公民身份号码 411525200609273614

签发机关: 固始县公安局

有效期限: 2026-02-11 - 2036-02-11



四诊初步诊断

望诊 (舌象分析)



舌苔图

分析提示【气滞血瘀】。特征识别：紫舌苔，舌质呈紫色，苔色深暗，多提示血瘀或寒凝血脉。

闻诊（体质诊断）

诊断结论：气滞血瘀
置信度：82.5%

体质标签：
气机不畅
音调波动
声音不连贯

问诊（症状问卷）

气虚质

切诊（脉搏检测）

心率：72.4 bpm
血氧：99 %

信号有效率：100 %
采样数：143

中医建议：
【脉象】缓脉（一息四至，不快不慢，从容和缓） 【主病】平人脉象，气血调和。

综合诊断建议

好的，作为专业中医四诊合参医生，我将严格依据您提供的四诊数据，为您生成一份综合分析报告。

中医四诊合参综合分析报告

患者：唐霄（男，19岁）

核心分析策略：本次分析以望诊（舌诊）数据为核心进行详细解读，闻诊、问诊、切诊数据作为辅助参考。

一、体质与证型分析

1. 体质判断：气虚质、血瘀质倾向

主要依据：

问诊问卷结论：明确提示为“气虚质”。

望诊舌象：舌质呈紫色，是血瘀质的典型舌象特征。

2. 证型分析：气滞血瘀证

主要依据：

望诊（舌诊）：这是本次分析的核心依据。数据明确指出“分析提示【气滞血瘀】”。具体特征为“紫舌苔，舌质呈紫色，苔色深暗”，这直接提示体内存在**血行不畅、瘀血内停**的病理状态。紫色舌是血瘀证最具特征性的指征之一。

闻诊（音频）：结论同样支持“气滞血瘀”，其特征标签“气机不畅、音调波动、声音不连贯”从声音角度反映了**气机郁滞、运行不通畅**的状态。气滞与血瘀常互为因果，气行则血行，气滞则血瘀。

问诊（问卷）：“气虚质”的结论是重要背景。气虚推动无力，可导致气滞与血瘀，形成“因虚致瘀”的复杂情况。

二、四诊数据详细解读

① 望诊（舌诊）详细分析

舌质颜色：紫色。这是最关键的诊断信息。中医认为，紫色主病有寒热之分，但结合患者年龄（19岁，阳气应较旺）及问卷体质（气虚非阳虚），此紫舌更倾向于**气滞血瘀**所致。血液运行受阻，舌体络脉瘀滞，故呈现紫色。

舌苔颜色与厚薄：数据描述为“紫舌苔，苔色深暗”。此描述将舌质与苔色合并，重点在于“深暗”之色，进一步印证了气血郁滞、不得宣通的状态。未提及厚腻、剥脱等，提示痰湿、阴伤等病理因素不突出。

舌体形态与湿润度：数据未提供关于舌体胖瘦、齿痕、裂纹及湿润度的具体描述。**此为信息缺失部分**，无法进行分析。

② 闻诊、问诊、切诊主要特征提要

闻诊：声音分析提示气机不畅，表现为音调波动、不连贯，与“气滞”病机相符。

问诊：体质辨识问卷结论为“气虚质”，为整体体质背景。

切诊：脉象报告为“缓脉”，属平和之脉，提示目前气血整体调和，未见紧、涩、细等与气滞血瘀高度相关的典型脉象。这可能提示瘀滞程度尚属初期，或脉诊信息采集有局限。

三、综合调理建议

基于“气滞血瘀”兼有“气虚”倾向的分析，建议以**行气活血、佐以益气**为调理原则，重在生活方式调整。

饮食建议：

多吃行气活血食物：如山楂、黑木耳、洋葱、玫瑰花（泡茶）、陈皮、金桔、醋等。

适当食用益气食物：如山药、小米、红枣、牛肉、鸡肉。

避免：少吃油腻、生冷、甜腻的食物，以免碍胃生湿，加重气机阻滞。

作息与运动建议：

规律作息：避免熬夜，夜间11点前入睡，有利于肝血归藏、气血调和。

坚持运动：运动是行气活血最好的方法。推荐每周进行3-5次有氧运动，如快走、慢跑、游泳、骑行等，以身体微微出汗、感觉舒畅为度，切忌过度大汗耗气。

穴位保健：

按揉太冲穴：位于足背，第一、二跖骨结合部前方凹陷中。是疏肝理气、调畅气机的要穴。

按揉血海穴：屈膝，在大腿内侧，髌底内侧端上2寸。有活血化瘀、引血归经的作用。

方法：每日每穴用拇指按揉3-5分钟，感觉酸胀为宜。

四、注意事项

本分析基于有限的AI采集数据，**不能替代执业中医师的面对面诊断**。舌象、脉象、问诊的细微之处需医生亲自甄别。

“气滞血瘀”证的形成与情绪密切相关。请注意保持心情舒畅，避免长期精神压力、抑郁或恼怒。

若伴有固定位置刺痛、胸胁胀闷、女性痛经有血块等症状，建议及时就医。

五、后续建议（缺失信息补全）

为获得更全面准确的诊断，建议在专业中医师处补充以下信息：

望诊补全：需明确**舌体形态**（是否胖大/瘦薄/有齿痕）、**舌面湿润度**（干/湿/滑）、以及**舌下络脉**（是否青紫、迂曲、增粗），这对判断血瘀程度及是否兼有痰湿、水停至关重要。

问诊补全：需详细了解**主要不适症状**（如疼痛性质与部位、情绪、睡眠、二便等）、**起病原因及病程**，这是辨证论治的核心依据。

切诊深化：需由医师亲自诊脉，体会脉象的**流利度**（有无涩脉感）、**力度**、**形态**，以验证和细化气滞血瘀的判断。

免责声明：本报告由AI基于有限数据生成，仅为健康科普与参考，不构成任何医疗诊断或治疗方案。如有健康问题，请务必咨询正规医疗机构。

报告生成时间：2026/4/1 00:59:53

本系统仅为中医诊断辅助工具，不具备医疗资质，输出结果仅供参考，不能替代专业中医师面诊及诊疗方案

签发医师：张翰

3个月